

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

RS-PLUTCHIK · ESCALA DE RIESGO SUICIDA

Plutchik's Suicide Risk Scale – Instrumento estandarizado de cribado rápido de ideación, antecedentes y letalidad suicida

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Plutchik's Suicide Risk Scale (SRS)
Nombre en español	Escala de Riesgo Suicida de Plutchik
Sigla oficial	RS-Plutchik (SRS)
Autores originales	Robert Plutchik, Herman M. van Praag, Hope R. Conte y Susan Picard (1989)
Adaptación hispanohablante	G. Rubio, M. Morales, A. Rubio, J. Cabrerizo, J. L. San Román, M. A. Sánchez-Teruel et al. (1998)
Año de publicación original	1989 (validación española en 1998)
Constructo primario	Riesgo de conducta suicida, antecedentes de tentativas, desesperanza y afectividad depresiva
Formato de administración	Autoinforme dicotómico (Sí / No) de cumplimentación ultrarrápida
Población diana	Población adolescente y adulta (≥ 14 años) evaluada en atención primaria, urgencias o salud mental
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (15 ítems)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de dominio público con fines asistenciales y académicos

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala de Riesgo Suicida de Plutchik** (RS-Plutchik) fue desarrollada en el marco del modelo bifactorial de Plutchik sobre la agresión dirigida hacia uno mismo (**inward-directed aggression**) y la agresión hacia otros. El instrumento fue diseñado con el objetivo clínico de discriminar de forma rápida, fiable y operativa a individuos normales de aquellos pacientes psiquiátricos con antecedentes de tentativas de suicidio o con riesgo inminente de consumación autolítica.

A diferencia de escalas que evalúan exclusivamente ideación activa presente, la escala de Plutchik integra antecedentes biográficos y marcadores bioconductuales de desregulación: consumo habitual de psicofármacos o inductores del sueño, insomnio de conciliación, impulsividad y pérdida de autocontrol, retraimiento y anhedonia social, pesimismo y desesperanza cognitiva profunda, autodesprecio existencial, estado depresivo actual, aislamiento civil (separación/viudez), antecedentes familiares de conducta suicida y sentimientos de cólera homicida/heteroagresiva. Esta combinación de factores confiere a la escala un elevado poder predictivo tanto en servicios de urgencias generales como en unidades de hospitalización psiquiátrica.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión / Área Clínica	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Ideación y Conducta Suicida	3 ítems	0 – 3	Ítems 13 (pensamientos de suicidio), 14 (comunicación verbal a terceros) y 15 (tentativa autolítica previa). Marcadores de máxima gravedad.
2. Desesperanza y Depresión	4 ítems	0 – 4	Ítems 5 (pesimismo), 6 (inutilidad personal), 7 (futuro sin esperanza) y 9 (ánimo depresivo actual). Núcleo cognitivo-afectivo.
3. Aislamiento y Anhedonia	2 ítems	0 – 2	Ítems 4 (desinterés en relacionarse) y 8 (sensación de fracaso absoluto y deseo de abandono en cama). Retraimiento abúlico.
4. Desregulación e Impulsividad	3 ítems	0 – 3	Ítems 1 (consumo habitual de fármacos/somníferos), 2 (insomnio) y 3 (sensación de pérdida inminente de autocontrol).
5. Factores Biográficos / Agresión	3 ítems	0 – 3	Ítems 10 (separación/viudez), 11 (suicidio en la familia) y 12 (rabia capaz de matar a alguien). Vulnerabilidad sistémica.
Puntuación Total RS	15 ítems	0 – 15	Suma dicotómica directa (Sí = 1, No = 0). Corte clínico estandarizado ≥ 6 puntos.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna	Alpha de Cronbach = 0.89 – 0.90	Excelente consistencia interna en la validación española de Rubio et al. (1998) en pacientes psiquiátricos y controles.
Fiabilidad test-retest	r = 0.88 (24-48 horas)	Alta estabilidad temporal a corto plazo en entornos clínicos de urgencias psiquiátricas.
Sensibilidad diagnóstica	88.0% (punto de corte ≥ 6)	Capacidad sobresaliente para detectar pacientes con antecedentes o riesgo de tentativas suicidas.
Especificidad diagnóstica	88.0% (punto de corte ≥ 6)	Elevada precisión para descartar falsos positivos en población no clínica o controles sin ideación.
Validez concurrente	r = 0.72 con BDI (Beck); r = 0.68 con HDRS	Correlación positiva y robusta con escalas estándar de gravedad depresiva y desesperanza.
Validez discriminante	ROC AUC = 0.94	Diferenciación altamente significativa entre pacientes con tentativa reciente frente a controles y pacientes sin riesgo.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Calificación dicotómica:** Cada respuesta afirmativa (**SÍ**) recibe un valor de 1 punto. Cada respuesta negativa (**NO**) recibe 0 puntos.
- **Puntuación Total:** Suma directa simple de los 15 ítems (rango posible: 0 a 15 puntos).
- **Manejo de omisiones:** Si el paciente omite 1 o 2 ítems no críticos, puede imputarse proporcionalmente. No obstante, si se omiten los ítems 13, 14 o 15, la escala carece de validez diagnóstica y debe realizarse exploración cualitativa directa e inmediata.
- **Jerarquía de ítems críticos (Red Flags):** Cualquier respuesta afirmativa en los ítems 13 (**ideación suicida**), 14 (**comunicación del deseo de morir**) o 15 (**tentativa suicida previa**) invalida una categorización de bajo riesgo, con independencia de que el puntaje total sea inferior a 6 puntos.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Categoría de Riesgo	Significación Clínica y Conducta Asistencial
0 – 2 puntos	Riesgo No Significativo	Ausencia de factores de riesgo activos detectados. Manejo clínico habitual según el motivo de consulta.
3 – 5 puntos	Riesgo Leve / Subumbral	Presencia de síntomas depresivos o estresores sin ideación activa letal. Requiere evaluación periódica y apoyo psicoterapéutico.
6 – 8 puntos	Riesgo Clínico Significativo	Punto de corte validado (≥ 6). Sensibilidad y especificidad del 88%. Indicio firme de riesgo suicida. Exige evaluación psiquiátrica formal y plan de contingencia.
9 – 15 puntos	Riesgo Suicida Alto / Crítico	Riesgo extremo de paso al acto. Coexistencia de desesperanza profunda, antecedentes y descontrol emocional. Considerar ingreso urgente.

REGLA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (RUBIO ET AL., 1998): Un puntaje ≥ 6 puntos en la RS-Plutchik obliga legal y clínicamente al facultativo a registrar formalmente la evaluación del riesgo autolítico en la historia clínica, contactar a la red de apoyo y activar las medidas de derivación o custodia asistencial.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Cribado en triaje o consulta ambulatoria:

- Aplicar la RS-Plutchik a todo paciente con clínica afectiva, crisis de angustia, abuso de sustancias o cambio brusco de conducta.

Paso 2: Valoración inmediata de los Ítems Críticos (13, 14 y 15):

- Si **Ítem 13 = Sí**, explorar intencionalidad, plan estructurado y accesibilidad a medios letales.
- Si **Ítem 14 = Sí**, contactar con allegados para contrastar los comentarios suicidas emitidos.
- Si **Ítem 15 = Sí**, revisar letalidad médica y circunstancias de rescate de tentativas previas.

Paso 3: Vía clínica de derivación según estratificación:

- **RS < 6 y sin ítems críticos:** Manejo ambulatorio en Atención Primaria o Salud Mental ordinaria.
- **RS ≥ 6 o presencia de ítem 13/14:** Derivación urgente a Psiquiatría. Retirar fármacos letales y armas de fuego del domicilio. No dejar al paciente solo bajo ninguna circunstancia.
- **RS ≥ 9 con plan activo o desesperanza terminal:** Indicación de traslado inmediato a Urgencias Hospitalarias para valorar internamiento psiquiátrico involuntario o voluntario en Unidad de Agudos.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 46 años, divorciado hace 8 meses, camionero de larga distancia, acude a Atención Primaria solicitando renovación urgente de benzodiacepinas para el insomnio rebelde.

Resultados en la RS-Plutchik:

- Puntuación Total: **8 puntos / 15** (Riesgo Suicida Significativo, superando el corte de 6).
- Ítems afirmativos: Ítem 1 (consumo habitual de somníferos), Ítem 2 (insomnio pertinaz), Ítem 3 (miedo a perder el control), Ítem 5 (pesimismo futuro), Ítem 7 (futuro sin esperanza), Ítem 9 (deprimido en la actualidad), Ítem 10 (separado/divorciado) y **Ítem 13 (Sí, pensamientos de suicidio recurrentes al volante)**.
- Ítems 14 y 15 negativos (no lo ha comunicado a la familia ni tiene intentos pasados).

Formulación y Abordaje Terapéutico: El cribado reveló un cuadro de Episodio Depresivo Mayor no diagnosticado con ideación suicida pasiva y activa ligada a la soledad laboral y al divorcio. El médico de primaria retuvo la prescripción libre de fármacos, contactó con el hermano del paciente para asegurar acompañamiento constante y derivó al paciente con carácter preferente al Centro de Salud Mental. Se inició tratamiento con Sertralina y psicoterapia focal cognitivo-conductual. A las 6 semanas de intervención, la RS-Plutchik descendió a 2 puntos, desapareciendo por completo la ideación autolítica.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS ROJAS ASISTENCIALES:

- **Ocultamiento deliberado:** Un paciente con intención suicida firme puede responder falsamente "NO" a los ítems para evitar ser retenido. Contrastar siempre con conducta no verbal y allegados.
- **Ítem 12 (rabia homicida):** La presencia simultánea de impulsividad agresiva y riesgo suicida eleva drásticamente el riesgo de suicidio ampliado o conductas violentas graves.
- **Acceso a medios:** Todo resultado ≥ 6 obliga a indagar sobre presencia de armas de fuego, acumulación de tóxicos o acceso a alturas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Ideación pasiva vs. Intención:** Distinguir entre el deseo de "no despertar" y la planificación activa estructurada.
- **Trastorno Límite de la Personalidad:** Las oscilaciones en la RS pueden ser muy rápidas. Requiere distinguir entre gestos parasuicidas comunicativos y conductas letales graves.
- **Depresión psicótica:** Si el paciente presenta delirios de ruina o culpa, el riesgo de suicidio es extremo independientemente del puntaje.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Plutchik, R., van Praag, H. M., Conte, H. R., & Picard, S. (1989). Correlates of suicide and violence risk: I. The suicide risk measure. *Comprehensive Psychiatry*, 30(4), 296–302. [https://doi.org/10.1016/0010-440X\(89\)90053-9](https://doi.org/10.1016/0010-440X(89)90053-9)
2. Rubio, G., Morales, M., Rubio, A., Cabrerizo, J., San Román, J. L., Sánchez-Teruel, M. A., & Bousoño, M. (1998). Validación de la escala de riesgo suicida de Plutchik en población española. *Archivos de Neurobiología*, 61(2), 143–152.
3. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
4. Baca-García, E., Díaz-Sastre, C., García Resa, E., Blasco, H., Braquehais Conesa, D., Oquendo, M. A., & de Leon, J. (2005). Suicide attempts and impulsivity. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 255(2), 152–156.